SDD 49 Sujet n°1

Spécialité : Anesthésie Réanimation

Date : 04/01/2024
Auteur : KUEVI-AKOE Marie
Relecteur(s) : VILLARD Sébastien, Lucie-Lou Vial

Domaine d'apprentissage principal	Examen clinique
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie diagnostique
Item(s) en lien avec la station	Item 336 - Coma non traumatique chez l'adulte et chez l'enfant Item 337 - Principales intoxications aiguës
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD-49 Ivresse aiguë SDD-28 Coma et troubles de la conscience SDD-340 Prise volontaire ou involontaire d'un médicament ou d'un médicament potentiellement toxique
Matériel nécessaire à la station	Lampe torche (ou téléphone portable avec lampe) pour réflexe photomoteur
Contexte de la station	Patient de 24 ans pris en charge par le SAMU pour somnolence dans un contexte d'alcoolisation (confirmée par le patient à la prise en charge initiale).

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne aux urgences de l'hôpital de Tours. Vous vous apprêtez à recevoir M. TREMENS, âgé de 24 ans, qui est conduit aux urgences par les pompiers pour état de somnolence dans un contexte d'alcoolisation festive. Les amis présents initialement ne rapportent pas de maladie connue chez ce patient.
Les paramètres vitaux sont les suivants : T° 37,6°C PA 90/60 mmHg FC 130 bpm FR 8 cycles par minute, SpO2 92% en air ambiant.

Votre externe est parti l'examiner pendant que vous finissez les transmissions avec les pompiers. Il commence à vous faire son compte-rendu, mais n'est pas sur d'avoir réalisé l'examen clinique correctement.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Enoncer les éléments à réaliser à l'examen clinique, ainsi que comment les réaliser pour évaluer son état neurologique et général

- Enoncer les éléments à rechercher à l'examen clinique et comment vous les réaliser pour la recherche étiologique

Vous ne devez pas :
- réaliser d'interrogatoire.
- formuler une hypothèse diagnostique / hypothèse étiologique.
- prescrire des examens non réalisables au lit du patient.
- prescrire un traitement.

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec professionnel de santé standardisé

ECOS TACFA

GRILLE D'ÉVALUATION

Aptitudes cliniques (max 15 items)		
1.	Énonce la stimulation auditive vigoureuse et répétée du patient, d'une voix forte. - appelle par le prénom. - demande d'ouvrir les yeux. - demande de serrer la main.	1 pt
2.	Énonce la stimulation tactile du patient.	1 pt
3.	Stimulation douloureuse : **(A MIMER, A NE PAS RÉALISER SUR LE PATIENT FICTIF)** - pression du lit unguéal aux quatres membres - et/ou par manœuvre de Pierre Marie Foix.	1 pt
4.	Évaluer la position des globes oculaires et rechercher un mouvement oculaire anormal.	1 pt
5.	Examen comparé bilatéral des pupilles - sans stimulation lumineuse. - puis avec stimulation lumineuse.	1 pt
6.	Rechercher des marbrures en regard des genoux, évaluer le temps de recoloration cutanée, évaluer la chaleur des extrémités.	1 pt si les 3/3 0,5 pt si 2/3 0 pt sinon
7.	Rechercher au moins 2 signes de lutte parmi : tirage sus claviculaire, sus sternal, intercostal, sterno cléido mastoidien, balancement thoraco abdominal.	1 pt
8.	Auscultation cardio pulmonaire : - auscultation des 4 foyers cardiaques - auscultation bilatérale et symétrique des champs pulmonaires	1 pt
9.	Demander la réalisation d'une glycémie capillaire.	1 pt
10.	Demander la réalisation d'un ECG.	1 pt
11.	Demande une évaluation des réflexes ostéo tendineux aux 4 membres (ne doit pas le réaliser).	1 pt
12.	Recherche d'une lésion traumatique en regard du scalp, de la tête ou en rétro auriculaire	1 pt si 2/3
13.	Recherche des myoclonies ou des sueurs	1 pt
14.		

15. .	Recherche d'une morsure latérale de langue et/ou une perte d'urine.	1 pt
	Communications et attitudes	
15.	**9. APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE**	1 pt

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
L'examen clinique est incomplet et désorganisé ou ne fait pas l'examen clinique	Les éléments recherchés sont peu ciblés, s'attarde à des manœuvres inutiles	L'examen clinique est raisonnablement organisé et couvre les éléments essentiels	L'examen clinique suit un enchaînement logique et est centré sur le problème, il n'y a pas de manœuvre inutile	L'examen est réalisé sans erreur avec un but précis, démarche intégrée

TOTAL (15 items)	**15 points**

<u>Consigne(s) à l'évaluateur :</u>
A communiquer également au candidat : Le candidat énonce son examen clinique tout haut et vous demande des éléments de réponse. Il peut mimer sur le patient fictif l'examen clinique qu'il réalise.

<u>Éléments de rétroaction :</u>
Face à un patient dans le coma, l'examen clinique doit de manière conjointe amener à une enquête étiologique et aux conséquences de ce coma (risque vital).
Il faut donc en premier lieu éliminer un arrêt cardio circulatoire (ici les paramètres vitaux sont donnés) en faisant un examen cardio circulatoire et respiratoire du patient.
- Recherche d'une valeur de glycémie capillaire se fait devant tout tableau neurologique.
- Dans ce contexte, il s'agit d'un patient GCS 9 dans un coma non fébrile.
- On recherche donc des signes en faveur d'un traumatisme.
- Devant l'absence de contexte évocateur, et l'absence de signe clinique évident de traumatisme crânien, cette cause semble peu probable mais à garder en tête car n'est pas toujours visible cliniquement.
- La suite de l'examen se concentre sur la recherche d'un déficit neurologique focal (AVC, thrombophlébite cérébrale), d'une raideur méningée (hémorragie méningée, méningo encéphalite bien que peu probable), de signe d'épilepsie, de signes d'HTIC. On recherche également des arguments en faveur d'une prise de toxique (alcool mais pas uniquement) en identifiant un toxidrome.
- Dans le même temps, on cherche des conséquences du coma prolongé et de la prise supposée d'alcool : hypoglycémie, inhalation, hypothermie, hypovolémie par déshydratation extracellulaire, fibrillation auriculaire, épilepsie….

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

<u>Contexte</u> :
Vous êtes interne aux urgences de l'hôpital de Tours. Vous vous apprêtez à recevoir M. TREMENS, âgé de 24 ans, qui est conduit aux urgences de l'hôpital de Tours par les pompiers pour état de somnolence dans un contexte d'alcoolisation festive. Les amis présents initialement ne rapportent pas de maladie connue chez ce patient.
Les paramètres vitaux sont les suivants : T° 37,6°C PA 90/60 mmHg FC 130 bpm FR 8 cycles par minute, SpO2 92% en air ambiant. La glycémie capillaire est mesurée à 4.5 mmol/L.

<u>Consignes</u> :
Vous devez réaliser en 7 minutes l'examen clinique du patient permettant une évaluation du coma.

Vous ne devez pas :

- réaliser d'interrogatoire.
- formuler une hypothèse diagnostique / hypothèse étiologique.
- prescrire des examens non réalisables au lit du patient.
- prescrire un traitement.

Attention : Vous avez 7 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Plan de la station ECOS :

Le candidat entre dans la pièce et le patient simulé se trouve sur le brancard.
L'évaluateur est derrière le bureau et donne les éléments de réponse au candidat.
Le candidat énonce tout haut les éléments de son examen clinique et l'évaluateur lui donne réponses. Il peut mimer sur le patient simulé les éléments qu'il souhaite évaluer.

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

Le patient simulé est allongé sur le brancard, il a les yeux fermés, les bras le long du corps et ne parle pas.

Identité du patient : ***(éléments d'interrogatoire à donner spontanément au candidat)***

M. TREMENS 24 ans, 1,75 m, 65 kgs

Mode de vie :

Étudiant en médecine. Fume 5 cigarettes par jour depuis 4 ans et consomme de l'alcool tous les deux jours.

Comportement global :

Le patient est allongé, les yeux fermés et ne parle pas spontanément. Il émet des sons incompréhensibles à la stimulation tactile. Il ne répond pas aux ordres simples. Lorsque l'étudiant demande à faire une pression unguéale, il bouge les membres en repoussant l'étudiant (localise la douleur).

Antécédents personnels :

Aucun

Antécédents familiaux :

Mère :HTA

Médicaments :

Aucun traitement médicamenteux au long cours.

Symptômes positifs : réponses à donner au candidat si il pose la question à chaque fois.

La glycémie capillaire est à 4.5 mmol/l (seuil < 2,75 mmol/l pour les non diabétiques).

			Stimulation

		Spontanée	*Sonore*	*Tactile*	*Douloureuse*
REPONSE	*Ouverture des yeux*	Non	Non	Non	Oui
	Réponse motrice	Non	Non	Non	Oui, aux 4 membres. Localise la douleur.
	Réponse verbale	Non	Non	Incompréhensible	Incompréhensible

Les globes oculaires sont centrés, sans mouvement anormal. Les pupilles sont symétriques intermédiaires réactives à la stimulation lumineuse.

Il n'existe pas de marbrures, le temps de recoloration cutanée est < 3 secondes, les extrémités sont froides et bleutées.

Il n'existe pas de signe de lutte.

L'auscultation cardio pulmonaire retrouve des bruits du cœur réguliers sans souffle et un doute sur des crépitants en base droite.

ECG : existence d'une tachycardie avec des extrasystoles auriculaires (pas de document fourni).

Il n'existe pas de lésion du scalp, ni rétro auriculaire. Il n'existe pas d'écoulement auriculaire/nasal.
Il n'existe pas de raideur de nuque.
Il n'existe pas de morsure latérale de langue.

Constantes :

T° 37,6°C PA 85/50 mmHg FC 130 bpm FR 8 cycles par minute, SpO2 92% en air ambiant
Glycémie capillaire 4.5 mmol/l.

ECOS TACFA

FEUILLET ORGANISATEUR

Plan de la station ECOS :

Le patient simulé est sur le brancard.

L’évaluateur est situé sur une chaise derrière le bureau.

Matériel nécessaire à la station :

- stéthoscope
- lampe torche
- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d’évaluation de papier de secours